

Nurse AI OS — 媒体资料包

nurse-ai-os.org · 2026年7月 · 媒体联络：great.ai.nurses@gmail.com

注意：本资料包中的链接均指向英文页面。英文原版：nurse-ai-os.org/assets/nurse-ai-os-media-packet.pdf

本资料包面向三类受众——普通公众、护理组织，以及 AI 架构师与科技媒体——提供可直接引用的表述，并附有速览要点、创始人简介、准确性说明及素材资源。资料包中的所有内容均可直接引用。

内容提要

Nurse AI OS 是一套免费的、受治理的护士专属个人 AI 操作系统——由一位拥有 22 年 ICU（重症监护室）经验的护士创建，让这个自主治理给药、任务委派与执业范围的职业，能够以同样的方式治理 AI。它为护理专业学生、临床一线护士、护理管理者和护士创业者提供一套内嵌护理安全文化的可用 AI 系统：每项任务都有风险分级、人工审批关卡、绝不接触任何患者数据的严格边界，以及经过签名、可验证的软件供应链。它有意保持贴近实践但不介入临床的定位：它承载的是围绕工作的职业生活——学习备考、专业认证、职业档案、科室运营、副业经营——并将临床核心永久划定为不予涉足的范围。ANA（美国护士协会）、NCSBN（美国州护理委员会全国委员会）与 AAN（美国护理科学院）的独立专业指南描述了安全的护理 AI 应有的样貌；Nurse AI OS 正是这些指南的落地实现——其研究性论断均经过对抗性验证，被驳回的结论会以更正形式公开发布。

速览要点

- **是什么**：一个受治理的个人 AI 操作层，专为护士打造，运行于开源的 Hermes Agent 运行时（Nous Research）。
- **服务对象**：同一治理主干上的四个受众模块——护理学生与教育者（Study OS）、临床一线与高级实践护士（Bedside OS）、护理管理者与领导者（Leader OS），以及护士创业者（Builder OS）。
- **费用**：创始年度内对护士和护理专业学生免费。
- **硬性边界**：绝不接触任何患者信息——“只要可能识别出患者身份，就算在内”。在录入环节即予拒绝，而非“先存储、后删除”。任何风险层级下都不做临床决策，永久如此。
- **安全模型**：EDENA 风险分级（● 可执行 / ● 须先经人工批准 / ● 暂缓，待治理审查 / ● 停止）——层级衡量的是风险，而非权限。核心信条：AI 起草，人类裁断，护士守护（AI drafts, humans judge, nurses steward）。
- **工程实现**：签名发布（固定密钥指纹 → 签名清单 → 逐文件校验和，校验失败即拒绝运行）、AI 自主编写技能须经人工分阶段审批、录入即拒绝的记忆规则，以及防锚定的“先下判断”交互模式。

- **证据纪律：**研究性论断均标注“已验证 / 来源转述 / 设计判断”标签；最近一轮对抗性验证确认了 25 项论断中的 24 项，唯一被驳回的论断已公开更正。
 - **创始人：**Robert Domondon（罗伯特·多蒙东），RN、CCRN、CSC、CMC——22 年 ICU 临床经验，13 年医疗管理经验，曾在菲律宾接受医师培训，曾任美国海军医院行政管理者。
-

面向普通公众

50 字介绍。 Nurse AI OS 是一套面向护士的免费 AI 助手系统，内置护理行业的安全规则：绝不接触患者信息，凡重要事项均由人工批准，并协助处理工作之外的一切——学习、认证、排班、职业发展——让护士以更轻盈的状态走向床旁。

150 字介绍。 护士是全世界最受信任的职业群体之一——和所有人一样，他们已经在用 AI 聊天机器人处理日常事务。Nurse AI OS 由一位从业 22 年的重症监护护士创建，为护士提供比开放聊天窗口更安全的选择：一套按照护理行业自身安全文化运行的个人 AI 系统。每项任务都有风险评级，凡属重要事项均须等待护士批准；患者信息则被直接拒绝——系统在设计上就无法成为绕开隐私保护的捷径。它做的是承载围绕工作的生活：为学生准备考试，为一线护士管理认证截止日期、帮助下班后减压，为管理者起草文书，为创业护士提供诚实的营销支持。创始年度内对护士和护理专业学生免费。系统的座右铭道出了它的故事：*AI 起草。人类裁断。护士守护。*

三条核心信息。

1. **护士已经在用 AI——这套系统让使用变得安全。** 选择从来不是“用不用 AI”，而是“受治理还是不受治理”。Nurse AI OS 是受治理的那个选项，而且由护士打造。
2. **患者隐私靠设计保障，而非靠承诺。** 系统在入口处即拒绝患者信息——从不存储，并以平实的语言明确说明这一点。
3. **人始终掌握主导权。** 每一项有实际影响的操作都须等待护士批准。AI 起草，护士决定。

建议报道角度。 一位在床旁工作 22 年的 ICU 护士，用护理行业的核查清单文化打造了一套 AI 系统，各行各业能从护士治理 AI 的方式中学到什么。“绝不接触患者数据”：一款以“拒绝做什么”作为开场白的 AI 工具。

金句引语。 “护士不应只是使用 AI——他们应当治理 AI。”（Nurses shouldn't just use AI — they should govern it.）—— Robert Domondon，创始人

面向护理组织

标准介绍段落（可自由引用）。 Nurse AI OS 是一个由护士主导、受治理的个人 AI 操作层，将护理行业已发布的人工智能专业指南落到实处。其设计与 American Nurses Association（美国护士协会）、NCSBN 及 American Academy of Nursing（美国护理科学院）已阐明的立场直接对应：AI 是护理判断的辅助——绝非替代；护士负有问责责任并始终在环；系统能力须在部署前经过测试，并持续复核验证。每项任务都在

EDENA 风险分级与人工审批关卡下运行；患者信息在录入环节即依严格的“无 PHI”边界予以拒绝；学术诚信 workflow 建立在过程透明之上，而非不可靠的检测评分；护理领导者还可获得可直接使用的模板——审查日志、工作流章程、科室 AI 问责章程——以履行专业指南赋予他们的监督职责。Nurse AI OS 在创始年度内对护士和护理专业学生免费。

要点。

- **它落实现有指南，而非另起炉灶。** 从 ANA/NCSBN/AAN 立场到系统组件的对应关系，已逐条引证发布于项目的《架构报告》——且这些引证经受住了对照一手来源的三票制对抗性验证。
- **它培养专业指南所预设的 AI 治理人才队伍。** 每位用户每天都在风险分级、审查关卡、升级规则和决策台账中实践——这正是临床 AI 到来之际各机构所需的职业直觉。受访护理院校普遍报告存在显著的 AI 素养缺口；学生模块正是针对这一缺口而设。
- **学术诚信按照证据指引的方式处理。** 检测工具存在有据可查的误报问题；Study OS 将诚信建立在披露模板、过程日志以及教育者“审阅加面谈”的工作流之上——绝不进行自动化指控。
- **护士审查是结构性安排。** 由具名护士组成的守护委员会（Steward Council）依据公开的核查清单审查共享技能，拥有隔离下架权，并执行 90 天复审周期。技能的发布绝不等同于背书或认证。
- **它不是什么（请直言不讳）：** 不是临床软件，不是决策支持系统，不接入电子健康档案（EHR），不属于 HIPAA 涵盖范围（且从不作此宣称），不是认证项目，也不作任何患者结局方面的宣称。

合作邀请。 有意开展试点、工作坊（资料包内附一套 90 分钟、可直接在科室使用的课程）或治理合作的护理组织、院校和工会，可通过 great.ai.nurses@gmail.com 联系本项目。

面向 AI 架构师与科技媒体

标准介绍段落（可自由引用）。 Nurse AI OS 是领域治理型个人 AI 的一个案例研究：它是构建在开源 Hermes Agent 运行时之上的治理层——凡运行时允许之处，安全属性由结构强制执行；凡做不到之处，则如实标注。分发采用“校验失败即拒绝”的签名供应链（固定密钥指纹、RSA 签名清单、执行前逐文件校验和验证）。智能体自主编写的技能——Hermes 会自主编写并改进自己的工具——被视为一等供应链风险面，一律进入人工审批暂存队列。记忆机制采用“录入即拒绝”的禁入清单，而非“事后删除”策略。风险分级附着于任务而非工具；四个受众模块在不分叉治理主干的前提下，各自定制技能与分级默认值。此外，项目的研究计划对自身论断实施三票制对抗性验证，并将被驳回的结论以更正形式公开——包括针对其自身营销内容的更正。

要点。

- **靠关卡，不靠感觉。** 该设计将常驻指令视为红线执行的必要但不充分条件。机械强制执行的节点（技能写入暂存、命令审批、签名发布拒绝检查）与模型自觉遵循的模式（如黄色层级的自审页脚，须在人工关卡处接受审计）之间的区别，在公开文档中被明确区分；具备交付拦截能力的输出校验器是已列明的下一步加固措施。当一位评审者指出这一区分问题时，项目更正了自己的文档。这种更正的习惯本身就是新闻点。

- **智能体本身是自己供应链的一部分。** 在一个会自己编写工具、自己维护记忆的运行时中，审查不能止步于安装环节：`write_approval` 暂存默认开启，安全扫描不问来源一律适用，“禁止记忆”（Do-Not-Remember）规则则针对运行时自身的记忆持久化行为强制执行。
 - **以技能结构实现防锚定。** 凡涉及决策相关事项，系统会在展示任何 AI 材料之前先征询人的判断——将自动化偏差的缓解措施编码为交互顺序，而非一句建议。
 - **“落实领域现有治理”的一个实操范例。** 护理行业早已发布相关要求（ANA、NCSBN、AAN）；本项目的贡献在于提供了将其转化为日常可用系统的机械层——这一模式可迁移至任何受监管的职业领域。
 - **查证凭据：**《架构报告》（HTML 与 PDF 版见 nurse-ai-os.org/architecture-report.html）载有“指南到结构”的对应关系及引证摘要；naio-os 标准对照表可供技术评审者查阅。
-

创始人

简版简介（50 字）。 Robert Domondon，RN、CCRN、CSC、CMC，重症监护护士，拥有 22 年 ICU 床旁工作经验、13 年医疗管理经验，曾在菲律宾接受医师培训，并曾主管一家美国海军基地医院的行政工作。他是 Nurse AI OS、NAIO Institute 和 Nurse Intelligence Network 的创始人。

长版简介（120 字）。 Robert Domondon 的职业生涯纵贯医疗全链条：在菲律宾接受医师培训并行医，在一处前美国海军基地主管医院行政，从事医疗管理十三年，提供 AI 应用咨询——并出于主动选择，在美国担任重症监护护士二十余年。这样的经历组合正是 Nurse AI OS 的设计蓝本：这套系统的缔造者签批过预算、起草过政策，也曾握住那位政策为之而写的患者的手。他的治理信条——“以设计实现治理；清晰与价值观先于速度”——贯穿于他创立的整个生态：NAIO Institute（标准与资格认证）、Nurse Intelligence Network（专业社区）、EDENA（伦理与风险层），以及 Nurse AI OS 本身。

生态体系一览

- **Nurse AI OS** —— 受治理的个人 AI 操作层（即本项目；生态的入口）。
 - **EDENA** —— Ethical Design & Enablement for Nursing Augmentation（护理增强的伦理设计与赋能）：每项任务运行其下的风险分类与关卡层。
 - **NAIO Institute** —— 面向医疗领域 AI 人才体系的标准、资格认证与合规框架。
 - **Florence-X** —— 受治理 AI 智能体工作队伍的编排控制平面；在每一层，最终决策权都归于人类。
 - **Nurse Intelligence Network（NIN）** —— 全球专业社区、峰会与播客（nurseintelligence.com）。
 - **Florence Media Network** —— 内容引擎；每一件内容在发布前均经 EDENA 分级与人工审核。
-

准确性说明——请这样描述我们

对本项目而言，把这些说对，比获得报道更重要。

- **请这样说：**“一套面向护士的受治理个人 AI 系统” (“a governed personal-AI system for nurses”) · “从设计上拒绝患者信息” (“refuses patient information by design”) · “创始年度内对护士和护理专业学生免费” (“free for nurses and nursing students during the founding year”) · “落实 ANA/NCSBN/AAN 专业指南” (“operationalizes ANA/NCSBN/AAN guidance”) · “构建于开源 Hermes Agent 运行时之上” (“built on the open-source Hermes Agent runtime”) 。
 - **请不要这样说：**“符合 HIPAA” (“HIPAA-compliant”) (它是个人工具，不属于 HIPAA 涵盖范围，且明确说明了这一点) · “临床 AI” (“clinical AI”) 、 “诊断” (“diagnoses”) 或 “决策支持” (“decision support”) (临床用途永久不在范围之内) · “为护士颁发认证” (“certifies nurses”) (完成课程绝不等于胜任力认证) · “改善患者结局” (“improves patient outcomes”) (本项目依政策不作任何患者结局、安全结局或合规方面的宣称) 。
 - **可直接引用的一句话边界：***“绝无 PHI，永远如此——只要可能识别出患者身份，就算在内。”* (No PHI, ever — if it could identify a patient, it counts.)
-

素材与链接

- **网站：** nurse-ai-os.org · **入门指引：** nurse-ai-os.org/start-here.html · **路径导览：** nurse-ai-os.org/pathways.html
 - **架构报告** (面向技术/高管读者)：nurse-ai-os.org/architecture-report.html (附 PDF)
 - **《Care Intelligence 白皮书》** (2026年6月)：nurse-ai-os.org/assets/care-intelligence-white-paper.pdf
 - **文章：**《护士需要的是一套 AI 操作系统，而不只是一个 AI》 (“Why Nurses Need an AI Operating System, Not Just an AI”) · 《可被驳倒的治理：Nurse AI OS 背后的证据》 (“Governance You Can Refute: The Evidence Behind Nurse AI OS”) ——均见 nurse-ai-os.org/nurse-station.html
 - **社区：** nurseintelligence.com · **YouTube：** [@NurseIntelligence](https://www.youtube.com/@NurseIntelligence) · **播客：** The Nurse Intelligence Podcast (Spotify)
 - **创始人照片：** 可应请求提供 (亦见 nurse-ai-os.org/about.html)
 - **采访、演讲、试点及治理事务垂询：** great.ai.nurses@gmail.com
-

提灯前行，秉笔存录。智能体提案，人类裁断，护士守护。(Carry the lamp. Keep the ledger. Agents propose. Humans judge. Nurses steward.)